

CLINICAL HISTORY TAKING & CARDIOVASCULAR SYSTEM (CVS)

أخذ السيرة المرضية السريرية والجهاز القلبي الوعائي

Dr. Yousif Yassen – Al-Ameed College of Medicine, 3rd stage (source: Macleod's Clinical Examination, 15th ed.)

د. يوسف ياسين – كلية الطب في جامعة العميد، المرحلة الثالثة (المصدر: كتاب ماكلويد للفحص السريري، الطبعة 15)

1. WHY HISTORY TAKING MATTERS AND THE 9 COMPONENTS | أهمية أخذ السيرة المرضية ومكوناتها التسعة

Why History Taking Matters | لماذا تهتم السيرة المرضية؟

- **Primary diagnostic tool:** up to **80%** of medical diagnoses are made from the history alone.
أداة التشخيص الأولى: يُستنتج ما يصل إلى **80%** من التشخيصات الطبية من السيرة المرضية وحدها.
- **Guides the physical exam:** it tells you which body systems need detailed examination.
توجّه الفحص السريري: فهي تبيّن أي أجهزة الجسم تحتاج إلى فحص مفصّل.
- **Directs investigation:** helps choose the right blood tests, X-rays or ECGs without wasting time.
توجّه الفحوصات: تساعد في اختيار التحاليل أو الأشعة أو تخطيط القلب المناسب دون إضاعة الوقت.
- **Saves time and resources:** prevents unnecessary, costly or painful tests.
توفّر الوقت والموارد: تمنع الفحوصات غير الضرورية أو المكلفة أو المؤلمة.
- **Core student skill:** history taking is tested in every clinical rotation and OSCE exam.
مهارّة أساسية للطلاب: تُمتحَن السيرة المرضية في كل دورة سريرية وفي امتحان OSCE.

The 9 Components of the Medical History | المكونات التسعة للسيرة المرضية

#	Component	المكوّن
1	Personal data (demographics)	البيانات الشخصية (الديموغرافية)
2	Chief complaint (CC) and duration	الشكوى الرئيسية ومدتها
3	History of present illness (HPI)	قصة المرض الحالي
4	Past medical history	السوابق المرضية
5	Past surgical history	السوابق الجراحية
6	Drug history and allergies	السوابق الدوائية والحساسية
7	Family history	السوابق العائلية
8	Social history and lifestyle	السوابق الاجتماعية ونمط الحياة
9	Review of other systems	مراجعة الأجهزة الأخرى

2. COMPONENTS 1–3 | 3 إلى 1 المكونات من

1. Personal Data (Demographics) | (البيانات الشخصية (الديموغرافية)

- **Full name and age:** confirm patient identity and age-related disease probability.

الاسم الكامل والعمر: لتأكيد هوية المريض واحتمال الأمراض المرتبطة بالعمر.

- **Sex/gender:** certain diseases are more common in males or females.

الجنس: بعض الأمراض أشيع عند الذكور أو الإناث.

- **Occupation:** identifies work-related exposures and physical demands.

المهنة: تحدد التعرضات المرتبطة بالعمل والمتطلبات البدنية.

- **Marital status and address:** context on social support and living location.

الحالة الاجتماعية والعنوان: سياق الدعم الاجتماعي ومكان السكن.

- **Date and time of admission:** crucial for establishing the disease timeline.

تاريخ ووقت الدخول: ضروري لتحديد الخط الزمني للمرض.

- **Source of history:** the patient, a relative or medical transfer notes.

مصدر القصة: المريض نفسه أو أحد أقاربه أو أوراق التحويل الطبية.

2. Chief Complaint (CC) and Duration | الشكوى الرئيسية ومدتها

- **Definition:** the main symptom that caused the patient to seek medical help.

التعريف: العرض الرئيسي الذي دفع المريض لطلب المساعدة الطبية.

- **Patient's own words:** record exactly what the patient says (e.g. 'chest pain', not 'angina').

بكلمات المريض نفسه: سجّل ما يقوله بالضبط (مثلاً «ألم في الصدر» وليس «الذبحة الصدرية»).

- **Include duration:** always specify how long the symptom has been present.

أذكر المدة: حدّد دائماً منذ متى يوجد العرض.

- Examples: 'Shortness of breath for 3 days'; 'Severe headache for 2 hours'.

أمثلة: «ضيق نفس منذ 3 أيام»؛ «صداع شديد منذ ساعتين».

- **Keep it short:** 1 or 2 symptoms maximum, not a long paragraph.

اجعلها قصيرة: عرض أو عرضان على الأكثر وليس فقرة طويلة.

3. History of Present Illness (HPI) | قصة المرض الحالي

- **Chronological story:** the full story of the main symptom from onset until today.

قصة زمنية متسلسلة: القصة الكاملة للعرض الرئيسي من بدايته حتى اليوم.

- **Symptom details:** when did it start? sudden or gradual? constant or intermittent?

تفاصيل العرض: متى بدأ؟ فجأة أم تدريجياً؟ مستمر أم متقطع؟

- **Associated symptoms:** what other symptoms happen at the same time (e.g. pain with nausea)?

الأعراض المرافقة: ما الأعراض الأخرى التي تحدث معه في الوقت نفسه (مثل ألم مع غثيان)؟

- **Previous episodes:** has the patient ever had this exact symptom before?

نوبات سابقة: هل عانى المريض من العرض نفسه من قبل؟

- **Patient's thoughts (ICE):** ask what they think is wrong (Ideas) and what worries them (Concerns).

أفكار المريض (ICE): اسأله عما يظن أنه الخطأ (الأفكار) وعما يقلقه (المخاوف).

3. SOCRATES – SYMPTOM ANALYSIS | تحليل العرض – SOCRATES

SOCRATES Framework | إطار SOCRATES

Letter الحرف	Meaning المعنى	Question السؤال
S S	Site الموقع	Where exactly is the pain or symptom located? أين يقع الألم أو العرض بالضبط؟
O O	Onset البداية	Did it start suddenly or develop gradually over hours/days? هل بدأ فجأة أم تطوّر تدريجياً خلال ساعات/أيام؟

Letter الحرف	Meaning المعنى	Question السؤال
C C	Character الطبيعة	What does it feel like? (sharp, dull, crushing, burning) كيف يبدو الإحساس؟ (حاد، كليل، ساحق، حارق)
R R	Radiation الانتشار	Does the pain spread anywhere else? (e.g. arm or jaw) هل ينتشر الألم إلى مكان آخر؟ (مثل الذراع أو الفك)
A A	Associated symptoms الأعراض المرافقة	Are there other symptoms such as sweating, nausea or vomiting? هل توجد أعراض أخرى مثل التعرق أو الغثيان أو القيء؟
T T	Timing / Duration التوقيت / المدة	How long does it last? Is it constant or coming in waves? كم يدوم؟ هل هو مستمر أم يأتي على شكل موجات؟
E E	Exacerbating / Relieving العوامل المفاقمة / المخففة	What makes it worse (exercise)? What makes it better (rest)? ما الذي يزيد سوءاً (الجهد)؟ وما الذي يخففه (الراحة)؟
S S	Severity الشدة	How severe is it on a scale from 1 to 10? ما شدته على مقياس من 1 إلى 10؟

4. COMPONENTS 4–9 | المكونات من 4 إلى 9

4. Past Medical History | السوابق المرضية

- **Purpose:** record all major illnesses the patient has had in the past.

الغرض: تسجيل جميع الأمراض الكبرى التي أصيب بها المريض سابقاً.

- **High-yield illnesses to ask about directly:** hypertension, diabetes mellitus, asthma or chronic lung disease, previous heart attacks or stroke, kidney or liver disease.

الأمراض عالية الأهمية التي يُسأل عنها مباشرة: ارتفاع ضغط الدم، داء السكري، الربو أو أمراض الرئة المزمنة، النوبات القلبية أو السكتة الدماغية السابقة، أمراض الكلى أو الكبد.

- **Hospital admissions:** ask whether they have ever been admitted to a hospital.

دخول المستشفى: اسأل إن سبق أن أدخل إلى مستشفى.

5. Past Surgical History | السوابق الجراحية

- **Surgical operations:** record any procedures performed in the past.

العمليات الجراحية: سجل أي إجراءات جراحية أجريت سابقاً.

- **Details:** name of operation, year performed and hospital.

التفاصيل: اسم العملية وسنة إجرائها والمستشفى.

- **Complications:** any bleeding or wound infection problems.

المضاعفات: أي مشاكل نزف أو التهاب في الجرح.

- **Anesthesia problems:** severe reactions to anesthesia in the patient or family.

مشاكل التخدير: تفاعلات شديدة مع التخدير عند المريض أو عائلته.

- **Blood transfusions:** note any transfusions received in past surgeries.

نقل الدم: دَوِّن أي نقل دم تلقاه في عمليات سابقة.

6. Drug History and Allergies | السوابق الدوائية والحساسية

- **Current medications:** drug name, dosage and frequency (e.g. Aspirin 100 mg daily).

الأدوية الحالية: اسم الدواء وجرعته وتكراره (مثل أسبرين 100 ملغ يومياً).

- **Over-the-counter drugs:** pain relievers, vitamins and herbal remedies.

الأدوية بدون وصفة: المسكنات والفيتامينات والأعشاب.

- **Medication adherence:** ask gently whether they regularly take their prescribed medicines.

الالتزام بالدواء: اسأل بلطف إن كان يتناول أدويته الموصوفة بانتظام.

- **Drug allergies:** always ask 'Are you allergic to any medications?'

الحساسية الدوائية: اسأل دائماً «هل لديك حساسية من أي دواء؟»

- **Allergy vs side effect:** true allergy causes rash/swelling; a side effect causes e.g. stomach upset.

الحساسية مقابل الأثر الجانبي: الحساسية الحقيقية تسبب طفحاً/تورماً، أما الأثر الجانبي فيسبب مثلاً اضطراباً في المعدة.

RED FLAG: document a true penicillin or severe drug allergy clearly in red!

علامة خطر: دَوْن حساسية البنسلين الحقيقية أو أي حساسية دوائية شديدة بوضوح باللون الأحمر!

7. Family History | السوابق العائلية

- First-degree relatives:** health status of parents, brothers, sisters and children.
أقارب الدرجة الأولى: الحالة الصحية للوالدين والإخوة والأخوات والأبناء.
- Cause of death:** if deceased, record the cause and age at death.
سبب الوفاة: إن كان متوفى فسجل السبب والعمر عند الوفاة.
- Inherited conditions:** ask whether heart disease, high BP, diabetes or stroke run in the family.
الحالات الوراثية: اسأل إن كانت أمراض القلب أو ارتفاع الضغط أو السكري أو السكتة تكرر في العائلة.
- Premature heart disease:** heart attacks in young relatives (< 55 years in men, < 60 in women).
مرض القلب المبكر: نوبات قلبية عند أقارب صغار السن (أقل من 55 سنة عند الرجال وأقل من 60 عند النساء).
- Familial patterns:** help identify genetic or shared environmental health risks.
الأنماط العائلية: تساعد في كشف المخاطر الوراثية أو البيئة المشتركة.

8. Social History and Lifestyle | السوابق الاجتماعية ونمط الحياة

- Smoking:** do they smoke? How many cigarettes a day and for how many years?
التدخين: هل يدخن؟ كم سيجارة يومياً ولكم سنة؟
- Alcohol intake:** how many drinks/units per week?
تناول الكحول: كم مشروباً/وحدة في الأسبوع؟
- Occupation and work environment:** their job and any exposure to dust or chemicals.
المهنة وبيئة العمل: عمله وأي تعرض للغبار أو المواد الكيميائية.
- Living situation:** who they live with; house or apartment with stairs.
ظروف السكن: مع من يعيش، وهل يسكن في بيت أو شقة فيها درج.
- Diet and exercise:** basic eating habits and level of daily physical activity.
الغذاء والرياضة: العادات الغذائية الأساسية ومستوى النشاط البدني اليومي.

9. Review of Other Systems | مراجعة الأجهزة الأخرى

Purpose: a quick screening checklist to ensure no major symptom was missed.
الغرض: قائمة فحص سريعة للتأكد من عدم إغفال أي عرض مهم.

System	Symptoms
الاجهاز	الأعراض
Cardiovascular	Chest pain, breathlessness, ankle swelling, palpitations ألم الصدر، ضيق النفس، تورم الكاحلين، الخفقان
القلبي الوعائي	
Respiratory	Cough, sputum, shortness of breath, wheeze السعال، البلغم، ضيق النفس، الصفير
التنفسي	
Gastrointestinal	Stomach pain, nausea, heartburn, bowel habit changes ألم المعدة، الغثيان، حرقة المعدة، تغير عادات الإخراج
الهضمي	
Nervous system	Dizziness, faints, headache, weakness الدوخة، الإغماء، الصداع، الضعف
العصبي	
Genitourinary and musculoskeletal	Urination problems, joint or muscle pain مشاكل التبول، ألم المفاصل أو العضلات
البولي التناسلي والعضلي الهيكلي	

5. CVS HISTORY – THE 5 KEY SYMPTOMS | السيرة القلبية الوعائية – الأعراض الخمسة الرئيسية

Core CVS Symptoms | الأعراض القلبية الوعائية الأساسية

The CVS history focuses on **5 key symptoms: chest pain, shortness of breath, palpitations, ankle swelling and dizziness/syncope.**

العرض 1: ألم الصدر | Symptom 1: Chest Pain

- **Common cause:** lack of blood flow to the heart muscle (**ischemia**).

السبب الشائع: نقص تروية العضلة القلبية (الإقفار).

- **Stable angina:** dull heaviness or tightness across the chest, triggered by walking/exertion and **relieved by rest**.
الذبحة الصدرية المستقرة: ثقل أو انقباض كليل في الصدر يثيره المشي/الجهد ويزول بالراحة.
- **Heart attack (MI):** severe crushing chest pain lasting **> 20 minutes**, with sweating and nausea.
النوبة القلبية (احتشاء العضلة القلبية): ألم صدري شديد ساحق يدوم أكثر من 20 دقيقة مع تعرق وغثيان.
- **Where it spreads:** often to the **left arm, neck or jaw**.

مكان الانتشار: غالباً إلى الذراع اليسرى أو الرقبة أو الفك.

RED FLAG: sudden excruciating 'tearing' chest pain spreading to the back is an emergency (**aortic dissection**)!

علامة خطر: ألم صدري مفاجئ وشديد جداً «كالتمزق» ينتشر إلى الظهر حالة طارئة (تسلخ الأبهر)!

ألم الصدر: قلبي مقابل غير قلبي | Chest Pain: Cardiac vs Non-Cardiac

Cardiac causes	Non-cardiac causes
الأسباب القلبية	الأسباب غير القلبية
Heavy, crushing or squeezing feeling; located centrally behind the breastbone ; brought on by exercise or stress ; eased by rest or nitrate spray ; may spread to the jaw or left arm. إحساس بالثقل أو السحق أو العصر؛ يقع في منتصف الصدر خلف عظم القص؛ يثيره الجهد أو الشدة النفسية؛ يخف بالراحة أو بخاخ النترات؛ وقد ينتشر إلى الفك أو الذراع اليسرى.	Muscle/bone: sharp pain, worse on touching the chest wall or moving. Lung/pleuritic: sharp pain, worse on a deep breath or cough. Stomach/oesophagus: burning heartburn feeling after eating. العضلات/العظام: ألم حاد يزداد باللمس أو الحركة. الرئة/الجبني: ألم حاد يزداد مع الشهيق العميق أو السعال. المعدة/المريء: إحساس حارق (حرقة) بعد الأكل.

العرض 2: ضيق النفس | Symptom 2: Shortness of Breath

- **Dyspnoea on exertion:** feeling breathless when walking or climbing stairs.

ضيق النفس الجهدى: شعور بالاختناق عند المشي أو صعود الدرج.

- **Orthopnoea:** shortness of breath when **lying flat** in bed. Key question: 'How many pillows do you sleep on to breathe comfortably?'
ضيق النفس الانتصابي (**Orthopnoea**): ضيق في النفس عند الاستلقاء على السرير. السؤال الأساسي: «كم وسادة تنام عليها لتتنفس براحة؟»
- **Paroxysmal nocturnal dyspnoea (PND):** waking suddenly at night gasping for air.
ضيق النفس الليلي الانتبابي (**PND**): الاستيقاظ فجأة ليلاً مع لهات لانتقاط النفس.
- **Why it happens:** fluid backs up into the lungs because the heart muscle is weak (**heart failure**).
سبب حدوثه: يرتد السائل إلى الرئتين لأن العضلة القلبية ضعيفة (قصور القلب).

العرض 3: الخفقان والدوخة | Symptom 3: Palpitations and Dizziness

- **Palpitations:** unpleasant awareness of the heartbeat ('fluttering', 'racing' or 'skipped beats'). Key request: ask the patient to **tap out the rhythm** with their finger.
الخفقان: شعور مزعج بنبضات القلب («رفرقة» أو «سرعة» أو «نبضات فائتة»). الطلب الأساسي: اطلب من المريض أن ينقر الإيقاع بإصبعه.
- **Dizziness and fainting (syncope):** temporary loss of consciousness due to reduced blood flow to the brain.
الدوخة والإغماء (**Syncope**): فقدان مؤقت للوعي بسبب نقص تدفق الدم إلى الدماغ.
- **Postural dizziness:** dizziness when standing up quickly (low blood pressure).

الدوخة الوضعية: دوخة عند الوقوف بسرعة (انخفاض ضغط الدم).

RED FLAG: fainting during physical exercise requires urgent heart evaluation!

علامة خطر: الإغماء أثناء الجهد البدني يستلزم تقييماً قلبياً عاجلاً!

العرض 4: تورم الكاحلين وألم الساق | Symptom 4: Ankle Swelling and Leg Pain

- **Ankle swelling (edema):** fluid building up in both legs/ankles due to heart failure.

تورم الكاحلين (الوذمة): تجمع السائل في الساقين/الكاحلين معاً بسبب قصور القلب.

- **Pitting edema:** pressing a thumb on the ankle leaves a visible dent.

الوذمة الانخماصية: الضغط بالإبهام على الكاحل يترك انخماصاً ظاهراً.

- **Intermittent claudication:** cramp-like leg pain when walking a short distance that stops with rest.

العرج المتقطع: ألم يشبه التشنج في الساق عند المشي لمسافة قصيرة ويزول بالراحة.

- **Cause:** narrowed arteries reducing blood flow to the leg muscles (**peripheral arterial disease**).

السبب: تضيق الشرايين مما يقلل تدفق الدم إلى عضلات الساق (مرض الشرايين المحيطية).

- **Simple question:** 'Do your legs hurt when walking, and does rest make the pain go away?'

سؤال بسيط: «هل تؤلمك ساقاك عند المشي، وهل تزول الآلام بالراحة؟»

عوامل الخطر ومثال الحوار وأخطاء الطلاب | 6. RISK FACTORS, SAMPLE SCRIPT AND STUDENT MISTAKES

عوامل الخطر القلبية الوعائية | Cardiovascular Risk Factors

- **Smoking:** major cause of coronary artery and peripheral vascular disease.

التدخين: سبب رئيسي لمرض الشرايين التاجية والأوعية المحيطية.

- **High blood pressure (hypertension):** damages blood vessel walls over time.

ارتفاع ضغط الدم: يُتلف جدران الأوعية الدموية مع الزمن.

- **Diabetes mellitus:** high blood sugar damages heart blood vessels (can cause 'painless' heart attacks).

داء السكري: يُتلف السكر المرتفع أوعية القلب (وقد يسبب نوبات قلبية «بلا ألم»).

- **High cholesterol (dyslipidaemia):** causes fatty buildup (plaques) in the arteries.

ارتفاع الكوليسترول (اضطراب الشحوم): يسبب تراكماً دهنيًا (لويحات) في الشرايين.

- **Family history:** early heart disease in close family members.

السوابق العائلية: مرض قلبي مبكر عند أقارب مقربين.

- **Unhealthy lifestyle:** lack of exercise, obesity and a high-fat diet.

نمط حياة غير صحي: قلة الرياضة والسمنة والغذاء الغني بالدهون.

مثال على حوار السيرة القلبية | Sample CVS History Script

- Student: 'What brings you to the hospital today?' Patient: 'I get this heavy pressure in my chest when I walk up stairs.'

الطالب: «ما الذي أتى بك إلى المستشفى اليوم؟» المريض: «أشعر بضغط ثقيل في صدري عند صعود الدرج.»

- Student: 'Does the pressure spread anywhere else?' Patient: 'Yes, sometimes up into my jaw and left shoulder.'

الطالب: «هل ينتشر الضغط إلى مكان آخر؟» المريض: «نعم، أحياناً إلى فكّي وكتفي الأيسر.»

- Student: 'What happens when you stop and rest?' Patient: 'It goes away completely after 3 or 4 minutes.'

الطالب: «ماذا يحدث عندما تتوقف وترتاح؟» المريض: «يزول تماماً بعد 3 أو 4 دقائق.»

- Student: 'Do you ever feel short of breath or notice swelling in your ankles?' Patient: 'A bit short of breath on hills, but no ankle swelling.'

الطالب: «هل تشعر بضيق في النفس أو تلاحظ تورماً في كاحليك؟» المريض: «ضيق خفيف في النفس على المرتفعات، لكن لا تورم في الكاحلين.»

أخطاء شائعة للطلاب يجب تجنبها | Common Student Mistakes to Avoid

- **Mistake 1:** writing a medical diagnosis in the chief complaint (write 'chest pain', not 'angina').

الخطأ 1: كتابة تشخيص طبي في الشكوى الرئيسية (اكتب «ألم الصدر» وليس «الذبحة»).

- **Mistake 2:** forgetting to record the duration of the main symptom.

الخطأ 2: نسيان تسجيل مدة العرض الرئيسي.

- **Mistake 3:** skipping past medical history questions such as diabetes or high blood pressure.

الخطأ 3: تجاوز أسئلة السوابق المرضية مثل السكري وارتفاع الضغط.

- **Mistake 4:** not asking about drug allergies.

الخطأ 4: عدم السؤال عن الحساسية الدوائية.

- **Mistake 5:** asking leading questions (ask 'What is the pain like?', NOT 'Is the pain sharp?').

الخطأ 5: طرح أسئلة إيحائية (اسأل «كيف هو الألم؟» وليس «هل الألم حاد؟»).

الخلاصة | Summary

- History taking is the foundation of diagnosis – up to **80%** of diagnoses come from the history.

السيرة المرضية أساس التشخيص – يأتي ما يصل إلى **80%** من التشخيصات منها.

- Always follow the **9 standard components** in order, from personal data to the review of systems.

اتّبع دائماً المكوّنات التسعة القياسية بالترتيب، من البيانات الشخصية إلى مراجعة الأجهزة.

- Use **SOCRATES** to analyze any symptom thoroughly.

استخدم **SOCRATES** لتحليل أي عرض بدقة.

- The CVS history focuses on **5 key symptoms** and always screens for the major risk factors: smoking, high BP, diabetes, lipids and family history.

تركز السيرة القلبية على **5 أعراض رئيسية** وتفحص دائماً عوامل الخطر الكبرى: التدخين وارتفاع الضغط والسكري والدهون والسوابق العائلية.